

Ақмола облысындағы қатерлі ісіктердің қауіп факторлары, аурудың таралуы және оны ерте анықтау

Жантемірова Д.А.

Ақмола облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы

Бүгінгі күнде онкологиялық аурулардың мәселесі әлемде және Қазақстан елі үшін аса өзекті болып тұр. Жыл сайын аурудың 3000 жағдайы тіркелетінін айтсақ та жеткілікті. Бүгінгі таңда онкологиялық аурулардың қауіп факторларына медициналық проблемалармен қатар экологиялық ахуалы мен жұртшылық арасында құлықтылық факторларының таралу үрдісі де жатады. Сол себептен қатерлі ісіктердің алдын алу амалдарына, біріншіден, ауруды уақытында анықтап, халық арасында зиянды әдеттер таралуының алдын алу, экологиялық факторлардың жақсаруына барынша ден қою.

Аталған жұмыстың мақсаты – Ақмола облысында жүргізілген скринингтік тексерістің ақпаратын ұсынумен қатар, аймақтар арасында көрсеткіштерді салыстыру және қатерлі ісік ауруларының пайда болу қауіп факторларына сараптама жасап көру.

Пайдаланған қайнар көздер – Республикалық денсаулық сақтау дамыту орталығының Ақмола облысы бойынша филиалының статистикалық мәліметтері мен өткізілген скринингтік тексеріс бойынша сараптамалық анықтама, Степногорск қалалық емханасының онкологиялық қызметі туралы анықтамасы, Ақмола облысының ресми сайты.

Онкологиялық аурулардың алдын алу шараларының негізгісі – ауруды уақытында анықтап, уақытында шара қолдану. Ауруды дер кезінде анықтауда скринингтік медициналық тексеріс маңызды роль атқарады.

Жыл басынан бұл бағытта Ақмола облысы бойынша да бірқатар жұмыс атқарылды.

2011 жылдың 1 қаңтар - 1 қыркүйек аралығында облыста жүргізілген тексеріс нәтижесінде мақсатты топтың 49,6 % қаралған болатын. Бұның ішінде қан жүйесі аурулары, диабет, офтальмологиялық аурулармен қатар онкологиялық ауруларға баса назар аударылды. Айта кететіні, скринингтік тексерілуден өткен тұрғындардың 61,9 %-ы сау.

Скринингтік тексерістер нәтижелеріне көшпес бұрын, жалпы облыстағы онкологиялық ауруларының жағдайларына назар аударайық.

Ақмола облысының денсаулық сақтау дамыту орталығының мәліметтері бойынша, 2011 жылдың 1-жартыжылдығында облыста онкологиялық ауру 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіші 104,3–ті құрады. 2010 жылдың 1-жартыжылдық бұл көрсеткіш 108,4 болатын. Аймақаралық деңгейде үстіміздегі жылдың 6 айында онкологиялық аурулар жағдайларының жоғары көрсеткіштері Сандықтау ауданы (170,9) мен Степногорск (157,9), Көкшетау (135,7) қалаларында тіркелген.

Өлім жағдайлары бойынша: 1000 тұрғынға шаққандағы облыс бойынша 2011 жылдың 1-жартыжылдық көрсеткіші – 65,7 (2010 жылдың үйлес мерзімінде – 63,4). Аймақаралық тұрғыдан (2011 жылы) Сандықтау (118,7), Зеренді (92,0) аудандары мен Степногорск (88,5) қаласының өлім структурасы жоғары болып қалып тұр.

Сонымен онкологиялық ауруларды анықтауға бағытталған скринингтік тексерістер негізгі 3 локализация бойынша өткізіліп келеді: сүт безі рагы, жатыр мойын рагы мен тік ішек пен тоқ ішек рагы.

В данном материале изложены данные результатов скрининговых обследований в Акмолинской области и приведены данные по распространению факторов риска, способствующих развитию онкологических заболеваний.

Аталған мақалада Ақмола облысында жүргізілген скринингтік тексерістің ақпаратын ұсынумен қатар, аймақтар арасында көрсеткіштерді салыстыру және қатерлі ісік ауруларының пайда болу қауіп факторлары жайында пікір жинақталған.

This paper presents outcomes of cancer screening and prevalence of risk factors for cancer in Ak-mola oblast.

Жалпы облыс бойынша сүт безі ісігін (СБР) анықтауға арналған тексеріске 22448 адам тиесілі, 2011 жылдың 1 қыркүйегіне олардың 12440-ы қаралды.

Аталған назоологияны анықтауда қолданған зерттеу тәсілі – маммография. Барлығы аталмыш тәсілмен – 12440 әйел тексеріліп, патологиясыз 11159 адам (81,9%) анықталды. 1196 әйелде, яғни 8,8%-да, сүт безінің зарасыз (қатерсіз) ісігі анықталса, қатерлі ісік – 16 адамда табылды (0,12%).

Аймақтарды салыстырсақ, бұл ретте Атбасар (қаралған әйелдердің 23,8 % СБР анықталған), Есіл (35,8%) аудандары мен Көкшетау қаласы (20,1%)

Өлбетте қатерлі ісікке қарағанда, қатерсіз ісікке заманауи медицина төтеп бере алатыны анық, алайда кейбір зарасыз болып саналатын ісіктердің уақыт өте келе қатерліге ауысуы мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Мәселен, көптеген зерттеулерге қарағанда, сүт безінің қатерсіз ісігі анықталған әйелдерде обыр ауруының даму қауіпі 50-60 процентке өседі.

Жатыр мойнының рагын анықтау арналған тексерістен 17669 әйел өтті. Текеріс кезінде қолданылған әдістер: кольпоскопия, цитология, жатыр мойнының биопсиясы. Кольпоскопиялық әдіспен 83,4%, цитологиялық зерттеуден қаралғандардың 86,7%-ы тексерілді. Нәжесінде жатыр мойын қатерлі ісігі – 2 адамда анықталды (0,02%). Жатыр мойнының биопсиясы 2390 адамға (9,90%) жасалып, қатерлі ісік – 5 (0,01%) жағдайда анықталды.

Жалпы облыс бойынша тексеруге тиесілі тұрғындардың 61,6 % қаралып, аурадың 433 жағдайы тіркелді, бұл қаралғандардан 2,5 % құрайды.

Аймақаралық тұрғыдан жатыр мойнының рагы Есіл ауданында 8 % жағдайда анықталса, өзге аудандарда бұл көрсеткіш 6 %-тен аспады.

Тоқ және тік ішек рагын анықтауда әйелдер мен ер адамдар арасында медициналық тексеріс гемокультурлық тест, ректороманоскопия, колоноскопия әдістері арқылы жүргізіледі. Гемокультурлық тест жүргізу нәтижесінде 8,7% жағдайда анықталды; ректороманоскопия әдісі аурудың – 2 (0,01%), ал колоноскопия қатерлі ісіктің 5 (0,02%) жағдайын көрсетті.

Ендігі кезекте жалпы жаңа өспелердің пайду болу себептеріне назар аударып, Ақмола облысының қауіп факторларына сарапатама жүргізіп көрейік.

Білетініміздей, рак жасушалары әр адамның ағзасында бар, бірақ олардың өзін көрсетіп, ауру туғызуы бірқатар факторларға тәуелді.

Әлбетте, өспелер мен ісіктердің пайда болу себептеріне көз жүгіртсек, бұл көп жағдайда ілеспелі аурулар. Мәселен, тік ішек рагының негізгі қауіп факторына созылмалы қабыну процестері (жара колиті, гемморой т.б.) жатады.

Қатерлі ісіктердің енді бір қауіп факторлары - вирустық инфекциялар. 16 және 18 типтегі адам папилломасының вирусы жатыр мойны ісігінің туындауына әсер етсе, В гепатитінің вирусы бауыр обырының қауіпін арттырады.

Сонымен бірге қатерлі ісіктердің пайда болуына салауатты өмір салтының ережелерін ұстанбау, яғни құлықтылық факторлар да әсер ететіні екені көпшілікке мәлім. Бұл темекіге деген тәуелділік, алкогольді мөлшерінен артық тұтыну, гиподинамия, дененің артық салмағы, тиімсіз тамақтану сияқтылар.

Айтқандай, жатыр мойын қатерлі ісігінің дамуына темекішегушілік тікелей әсер етеді. Жатыр мойны каналының шырышы мен қынабында катонини, никотин түрінде қалатын темекішегушіліктің өнімі әйел ағзасына зиянын тигізеді.

Қозғалыс енjarлығы, яғни дененің белсенділігі, артық салмақ сүт безі мен тоқ ішек рагына әкеп соғуы мүмкін.

Скринингтік бағдарламысының және бір мақсаты, ауруларды анықтап, уақытында медициналық көмек көрсету ғана емес, жұртшылық арасында қауіп факторларының таралу үрдісін де анықтау. Тексерістен өткен облыс тұрғындарының арасында арнайы сауалнама жүргізіліп келесі фактілер тіркелді. Қаралғандардың 5,6% темекі шегеді; 0,7% ішімдікті мөлшерден артық тұтынады; қаралғандардың 2,87%-де дене салмағы индексі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белгілеген нормадан асқан; және 2,62% тұрғынның дене белсенділік көрсеткіші тым төмен көрінеді.

Ауданаралық тұрғыдан: темекішегушілік Қорғалжын және Есіл аудандары тұрғындары арасында көбірек тараған –31,2% және 19,39 % сәйкесінше; Ішімдікті артық тұтыну – Қорғалжын ауданы (5,9%); дененің артық салмағы – Аршалы ауданында артып тұр (12,32%); дене белсенділігінің төмендігі – Жарқайың (52,3%) мен Қорғалжын (41,7%) аудандарында.

Дегенмен осы тұста айта кететін жайт, 2011 жылдың басында Ақмола облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем мекемелерінің емделушілері арасында жүргізген сауалнама нәтижелерінде айтарлықтай айырмашылық бар. Мысалы, сауалнамаға қатысқандардың темекі

шегетіндерінің үлесі -21 %, ішімдікті тұтынатындар – 38,2 % (артық тұтыну бойынша арнайы сауалнама жүргізілмеді), және дене белсенділігіне мүлдем көңіл аудармайтандары -36,9 %.

Аудандарды өзара салыстырсақ, темекішегушілер қатары Атбасар ауданында көбірек, алкогольді тұтыну бойынша – Ақкөл ауданы мен Сандықтау ауданы алдыңғы қатарда қалып отыр.

Онкологиялық аурулар қолайсыз экологиялық жағдаймен де байланысты.

Ақмола облысының экологиялық жағдайына келсек, Қ.Сатпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетінің жүргізген зерттеулеріне қарағанда, облыстың көптеген жерлерінде топырақ пен тау жыныстары жоғары табиғи радиациялық фонмен ерекшеленеді. Мәселен, облыс қалалары мен ауыл үйлеріндегі радон концентрациясы шегі мүмкін шамасынан асып тұр - 200 Бк/м³

(куб метрге Биккерель). EVS 839:2009 «Ішкі климат» стандартына сәйкес тұрғын үйлердегі, жұмыс орындарында радонның ортажылдық 200 Бк/м³-ден аз болуы тиіс.

Ондай жерлер тізімінде – ал зерттеулерге сүйенсек, радон бойынша қауіпті зоналарға облыстың 64 тұрғынды мекені жатады - Сандықтау ауданының Балкашино поселкісі де бар. Химия курсынан білетініміздей, радон өкпе обырының дауымына әсер етуші қауіп факторларының бірі деп саналады. Әсіресе темекішегушілікпен қосылғанда тіпті қауіпі артады. Жоғарыда көрсетілгендей, Сандықтау ауданы онкологиялық аурулар бойынша жайсыз болып отыр.

Әрине, аймақтағы экологиялық проблемалар рак ауруының таралуына тікелей әсер етіп, таукен байыту және өндірістің онкологиялық аурулардың туындауына сөзсіз байланысты екенін пайымдау дұрыс болмас. Себебі қандай да болсын мәселе арнайы зерттеу мен анықтауды талап етеді.

Степногорск қаласы бойынша онкологиялық аурулар жағдайына тағы бір оралсақ. 2011 жылдың басынан онкопатологиямен алғаш рет 101 адам тіркелді, олардың 4 стадияда 9 жағдай, көзге көрінетін 3 стадияда 10 жағдай тіркелді. Степногорск мамандарының жүргізген сараптамасы бойынша, 3 стадиядағы асқынған жағдайлардың негізгі себебі – аурудың сыр бермей ағыу (3 жағдай), кеш қаралу (4). Яғни экологияның әсерінен басқа азаматтардың кеш қаралып, медицина қызметкерлерінің көмегіне дер кезінде жүгінбеуі обырдың асқынған жағдайларына әкеледі. Ал бұл профилактикалық тексеріс мағыздылығының қажеттілігін дәлелдей түседі.

Айтылғандай қатерлі ісіктің алдын алуда зиянды әдеттерден арылып, экологиялық жағдайд жақсарту да маңызды.